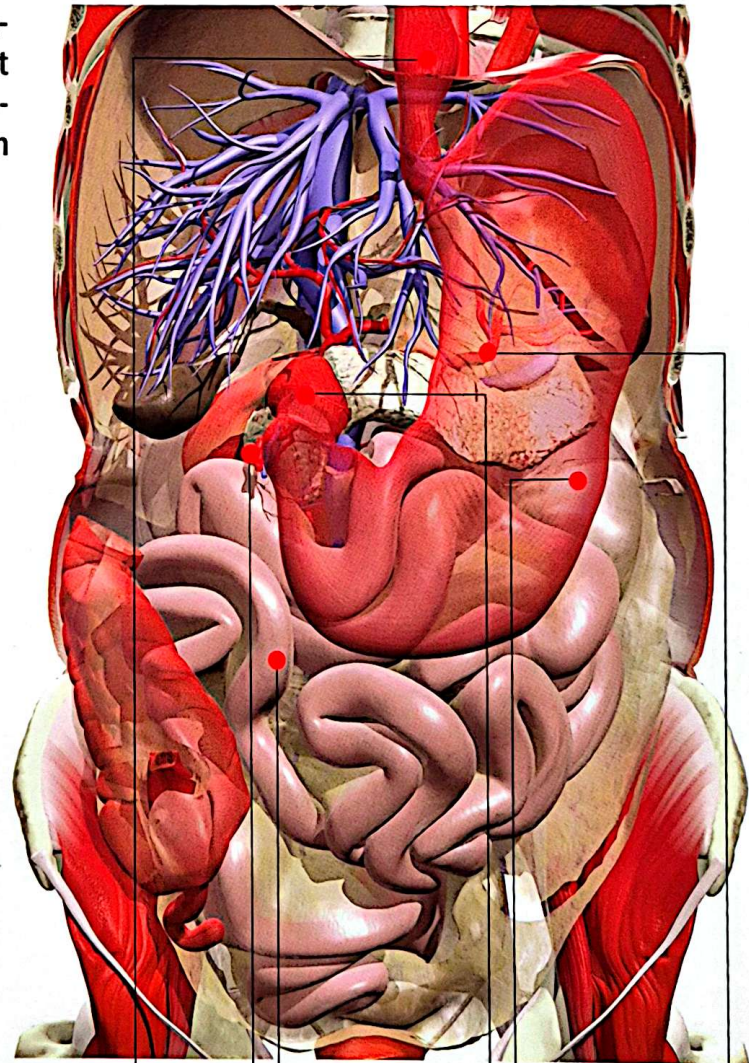


LES INTESTINS

L'usine de traitement des déchets

L'intestin grêle est le lieu de la digestion finale des aliments et de l'absorption des nutriments. Le gros intestin ou côlon a pour fonction essentielle de concentrer les déchets et de les éliminer sous forme de matières fécales, mais aussi de récupérer l'eau et le sodium contenus dans les résidus.

L'intestin grêle



► ŒSOPHAGE

► ILÉON

► ARTÈRE GASTRIQUE

► PYLORE

► ESTOMAC

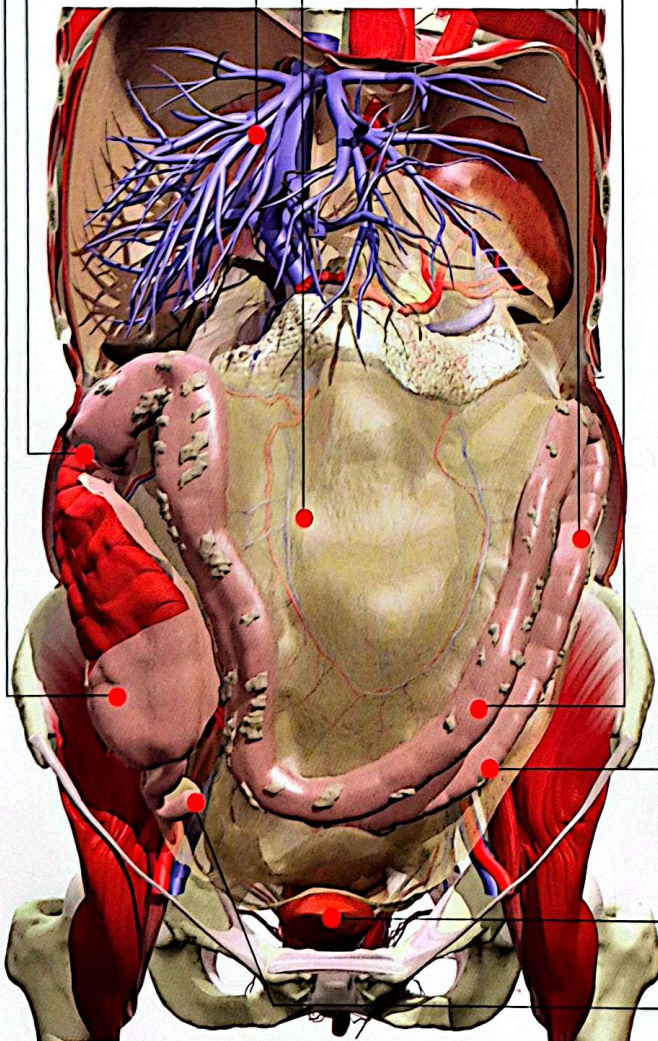
► DUODÉNUM

► CÔLON SIGMOÏDE

► VESSIE

► APPENDICE

- VEINES HÉPATIQUES
- CAECUM
- CÔLON ASCENDANT
- CÔLON TRANSVERSE (RABATTU VERS LE BAS)
- EPIPLAN (MÉSOCÔLON)
- CÔLON DESCENDANT

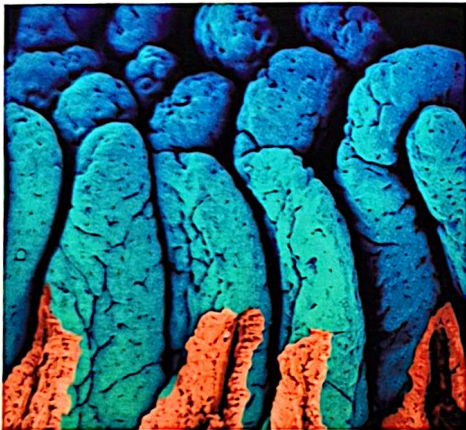


Le côlon

L'intestin grêle

► À l'œil nu

L'organe le plus long du tube digestif mesure 6 à 7 mètres quand les muscles lisses sont détendus, mais moins de la moitié seulement à l'état vivant, sur environ 2,5 cm de diamètre. Il est disposé dans la cavité abdominale avec de multiples circonvolutions qui forment les anses intestinales.



L'intestin grêle est très mobile, favorisant la digestion des aliments.

L'intestin grêle comprend trois grandes parties :

- le **duodénum** commence au niveau du pylore, un muscle qui le sépare de l'estomac ; il reçoit la bile du foie et les sécrétions pancréatiques indispensables à la digestion
- le **jéjunum**, partie intermédiaire.
- l'**iléon**, qui se termine dans le gros intestin au niveau de la valvule iléo-caecale.

Tout l'intestin grêle est relié à la paroi abdominale postérieure par le **mésentère**, repli de la membrane de l'abdomen ou péritoine, riche en vaisseaux sanguins et en vaisseaux lymphatiques.

L'intestin grêle est parcouru de contractions rythmées, les ondes péristaltiques, qui partent du duodénum et vont jusqu'au côlon pour faire progresser le bol alimentaire.

► Au microscope

La surface interne ou muqueuse de l'intestin grêle comporte de multiples structures en forme de doigts, les **villosités**, qui multiplient cinq à dix fois sa surface initiale. Ces villosités, séparées par des glandes produisant de multiples sécrétions digestives, sont chacune le siège d'une infinité de minuscules microvillosités, visibles au sommet de chaque cellule intestinale. Ce sont elles qui permettent à la surface d'absorption intestinale d'atteindre deux cent mètres carrés.

Le côlon

► À l'œil nu

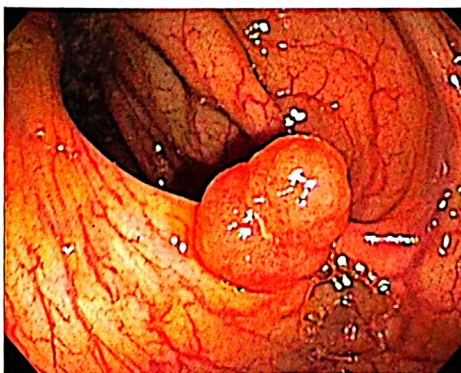
Le côlon mesure 1,50 à 1,80 m de longueur pour un diamètre de 3 à 8 cm chez l'adulte. Il est disposé en cadre dans l'abdomen. Le côlon comprend six grandes parties :

- le **caecum**, situé dans la fosse iliaque droite, qui reçoit l'aboutissement de l'intestin grêle et se prolonge vers le bas par l'appendice,
- le **côlon ascendant** qui monte sur le flanc droit de l'abdomen,
- le **côlon transverse** qui passe de droite à gauche devant l'estomac et tous les autres organes abdominaux en formant un arc de cercle convexe vers le bas,
- le **côlon descendant** qui débute sous les côtes gauches et descend dans la cavité abdominale,
- le **côlon sigmoïde** situé dans la fosse iliaque gauche où il forme un S,
- le **rectum** ou ampoule rectale, la partie dilatée située dans le bassin.

► Au microscope

Le côlon ne possède pas de villosités et compte peu de glandes digestives, mais il sécrète un mucus abondant à l'approche du rectum. Sa paroi est riche en fibres musculaires lisses circulaires et longitudinales, qui assurent des contractions rythmées plus lentes que celles de l'intestin grêle et ne surviennent que toutes les 30 minutes environ.

Une flore bactérienne abondante permet la fermentation de glucides complexes et la putréfaction de protéines quand ces aliments n'ont pas été digérés dans l'intestin grêle. Cette action libère chaque jour environ 500 ml de gaz dont certains, méthane ou hydrogène sulfuré, sont malodorants. La flore bactérienne colique produit aussi la quasi-totalité des vitamines B et K dont l'organisme a besoin.



Kyste vu au microscope.

L'exploration du côlon

Les médecins disposent de deux examens pour explorer l'anatomie du côlon :

- l'**endoscopie** par introduction d'une fibre optique, capable de remonter tout le côlon mais qui doit s'arrêter à la valvule iléo-caecale. Elle permet un examen visuel direct par l'examineur et autorise certains actes techniques comme un prélèvement de tissu ou la destruction d'un petit polype.



Recherche d'un polype par endoscopie.

- la **radiographie avec lavement baryté**, après injection de produit opaque aux rayons X, bien moins utilisée aujourd'hui.

Des pathologies intestinales

► La colite

Il s'agit d'une inflammation aiguë ou chronique du côlon. C'est un terme qui recouvre à la fois des infections bactériennes, virales, parasitaires ou médicamenteuses (dues par exemple à un laxatif irritant, ou à la suite d'une radiothérapie...). Elle se manifeste par une diarrhée, associée ou non à des douleurs abdominales. Une coloscopie est faite afin d'effectuer une biopsie pour rechercher le germe en cause. Un traitement antibiotique ou des corticostéroïdes sont souvent prescrits. On parle de recto-colite lorsque l'inflammation concerne à la fois le côlon et le rectum.

► La colopathie fonctionnelle

Il s'agit d'un trouble très répandu du fonctionnement du côlon, sans lésion organique décelée. On parle souvent du **syndrome de l'intestin irritable**. Elle se manifeste par des douleurs de type spasmodique le long du côlon et des troubles du transit intestinal (constipation et/ou diarrhée). Bien souvent le diagnostic est limité à un examen clinique. Le traitement repose essentiellement sur une alimentation diversifiée, en insistant sur les fibres. Des médicaments antispasmodiques peuvent venir également soulager le malade. Les troubles liés à cette maladie sont certes gênants, mais se révèlent bénins et sont souvent liés à l'état psychologique des patients.